合理用药
双人逐页演讲稿

配套文件：合理用药_双人 35 分钟.pptx｜30 页主讲＋3 页文献附页＋2 页图片来源附页

目标：面向具有高中生物基础的非医学专业大一学生，学会处理常见用药选择并识别误区。全部小苏故事均为虚构情境；真实研究单独标明。

35 分钟时间与分工

部分	主讲页	时间	内容
第一部分	1—5	00:00—05:00	基本原则
第二部分	6—19	05:00—22:00	五类宿舍误区
第三部分	20—26	22:00—30:00	安全用药方法
第四部分	27—30	30:00—35:00	简单综合选择题与收尾

甲主讲第 1—16 页，计划 16 分 55 秒；乙主讲第 17—30 页，计划 18 分 05 秒。第 29 页甲补充约 15 秒，第 30 页共同收尾，实际发言时间更接近。第 16 页末交接，不中途介绍新身份。

互动时，一人主持，另一人观察举手并翻页。不要求同学解释观点，不询问私人疾病史。参考资料页设为隐藏，课堂主线不会自动进入附页。

排练与控时

计时是演讲目标，不是自动播放。稿件文字量以本次生成的逐页讲稿为准，另有停顿、读题、举手与同桌讨论，按自然讲解语速排练后校准。首次完整计时，优先把总时长控制在 34—36 分钟；不要为凑时间机械拖慢每句话。

到第 5 页末应约 5 分钟，第 19 页末约 22 分钟，第 26 页末约 30 分钟。超时 1 分钟：压缩第 18 页重复解释约 30 秒，并将第 19 页同桌讨论与点评合计缩短 30 秒。提前 1 分钟：按稿中停顿完整读图，补充讨论第 8 页的信息缺口和第 13 页的两种比较假设，不要临时增加医学结论。

使用 PowerPoint 演示者视图查看备注。翻页采用手动点击，不设自动计时；答案页在投票后再显示。把封面的“同学甲/同学乙”替换成姓名。正式展示前，在实际电脑上检查字体和投影。

01｜合理用药：给宿舍药箱上堂课

主讲：甲　建议：45 秒　累计：00:00—00:45

舞台提示：甲主讲；乙操作翻页。

甲：大家好。今天我们聊一个进入大学后越来越需要自己做决定的问题：身体不舒服时，药到底该怎么用？离开父母的提醒，宿舍药箱、室友推荐和手机搜索，可能成了我们的第一反应。但名字熟悉，不代表适合自己；药吃得多，也不代表好得快。接下来我们用五类校园情境和几轮举手选择，练习几个能直接用上的判断。我们不考药名，也不背剂量表，目标是学会看什么、问什么，以及什么时候应该就医。

02｜今天的路线：从会判断，到会行动

主讲：甲　建议：45 秒　累计：00:45—01:30

舞台提示：移至封面后的第 2 页；先交代路线，再进入原第 2 页的开场选择题，不提前揭晓答案。

甲：先用这张路线图，看看今天怎么给宿舍药箱上堂课。前五分钟建立判断原则；接着用十七分钟看五类校园误区：重复成分、抗生素、备考提神、抗过敏药，以及药物与饮酒。然后用八分钟练习安全用药的方法，最后五分钟替小苏做一次综合选择。甲负责前半段，乙负责后半段，举手互动已包含在时间里。大家只需选下一步，不用背药名或计算剂量。现在进入第一个情境：室友感冒了，你会先做哪一步？

03｜室友感冒了，你先做哪一步？

主讲：甲　建议：90 秒　累计：01:30—03:00

舞台提示：10 秒阅读＋三轮举手约 25 秒；不追问个人用药史。

甲：小苏流鼻涕、喉咙不舒服，明天还有课。药箱里有上次剩下的药，室友也递来一盒。沿用经验、先核信息、按症状挑药，三个方案都像是在解决问题。信息还不完整时，你选哪一个第一步？

【静默 10 秒；A、B、C 依次举手，各约 5 秒】

甲：先保留选择。上次有效不代表这次适用，包装上的症状描述也不能代替核对；下一页看判断需要哪些信息。

04｜合理用药，要同时过四关

主讲：甲　建议：60 秒　累计：03:00—04:00

甲：合理用药可以用四个词记住：安全、有效、经济、适宜。安全不是承诺任何药都没有风险，而是识别禁忌和可能的不良反应。有效，是药物针对的问题与实际需要相符。经济，是在满足治疗需要的前提下，避免不必要的药物和花费。适宜，则提醒我们，同一个药对室友合适，对自己不一定合适，年龄、过敏史、正在使用的其他药物，都可能影响选择。所以开场选 B，是先把这些信息补齐，而不是看到一个症状就直接往药箱里伸手。

本页依据：S1

05｜鼻子舒服了，为什么上课却犯困？

主讲：甲　建议：60 秒　累计：04:00—05:00

甲：小苏吃了抗过敏药，鼻子舒服了，上课却开始犯困。药明明在起作用，怎么还会影响精神？先看图里的两个位置：组胺在鼻部参与部分过敏反应，在脑内也参与维持清醒。部分抗组胺药能进入脑内，影响相关信号，因此可能在缓解过敏症状的同时让人困倦。这就是生物课里的“信号传递”在生活中的一个例子：同一种信号物质，在不同位置可以参与不同功能。不是所有抗过敏药都一样，也不是人人都会困。对我们有用的结论是：选择药物时，不只问能不能缓解症状，还要查嗜睡提示，向药师说清白天有课或需要通勤；已经困倦时，避免驾驶、骑车等高风险活动。后面再展开解释这个机制。

本页依据：S8

06｜两盒药，是“双保险”还是撞车？

主讲：甲　建议：75 秒　累计：05:00—06:15

甲：小苏觉得头痛还没缓解，拿起另一盒感冒药。室友说，名字不同，一盒管头痛、一盒管感冒，听起来像双保险。三格漫画从不舒服，到听起来合理的建议，再把判断停在药盒背面。症状宣传不同，不代表有效成分不同。下一页不算剂量，只把成分摆在一起，看双保险有没有变成重复。

本页依据：S2

07｜药盒不同，成分可能“撞车”

主讲：甲　建议：60 秒　累计：06:15—07:15

甲：左边是单方退热止痛药的教学标签，只有对乙酰氨基酚；右边的复方感冒药示例另有马来酸氯苯那敏和盐酸伪麻黄碱。组成不完全相同，但同一个红色成分块出现了两次，其他成分的不同不能抵消重复。先把真实说明书的成分逐项对照，再核规格、已经服用的时间和用量，拿不准就带药盒问药师。这两张教学标签不对应具体产品，不给出剂量；不同产品的组成和要求可能不同。

本页依据：S2

08｜18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

主讲：甲　建议：60 秒　累计：07:15—08:15

甲：18 点，小苏服过一种复方感冒药；20 点仍然头痛，想加另一盒退热药。这两个时间只是故事线索，不表示隔两小时就能加药。现在要补齐两盒药的具体药名、成分、规格，以及今天何时用了多少。核对重复和累计使用，不能靠症状还在就自行加量，也不能套统一间隔。怀疑超量或误服应及时寻求医疗帮助；症状持续、加重也应按说明书就医提示处理。下一页只选获取这些信息的下一步。

本页依据：S2

09｜室友群的三条消息，你给哪条点赞？

主讲：甲　建议：75 秒　累计：08:15—09:30

舞台提示：阅读 10 秒；举手约 25 秒；其余时间复述问题并转场。

甲：室友群里弹出三条消息。A 让我们找重复成分，B 建议错开服药时间，C 让我们补齐今天的药名、规格和时间。可以给多条消息点赞，选择的是现在有助于判断的建议，不是替小苏开药。

【静默 10 秒；逐条举手各约 5 秒，可多次举手】

甲：请保留选择，下一页看哪些建议补齐了信息，哪些只是让安排听起来谨慎。

本页依据：S2

10｜答案 A＋C：先把两类信息凑齐

主讲：甲　建议：30 秒　累计：09:30—10:00

甲：可以同时给 A 和 C 点赞。A 找到共有成分，C 补齐具体规格与已服记录，两条合起来才更有助于判断。B 听起来考虑了时间，但并没有核清成分、规格和累计使用；不能靠错开就推定合用安全。先不自行叠加，带齐这些信息问药师。

本页依据：S2

11｜案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

主讲：甲　建议：75 秒　累计：10:00—11:15

甲：第二个误区是把抗生素当成感冒时的保险药。回到高中生物，细菌具有细胞结构，病毒没有完整的细胞结构，需要利用宿主细胞复制。不同类别的抗生素，可以作用于细菌的细胞壁合成、蛋白质合成等过程；对引起普通感冒的病毒，它们没有相应的治疗作用。所以流鼻涕、嗓子痛，并不能自动推出“应该吃抗生素”。当然，出现这些症状也可能有其他原因，少数病毒感染之后还可能发生细菌感染，是否需要抗生素需要评估。我们能做的是描述症状、接受判断，而不是自己拿剩药试试看。

本页依据：S4; S11

12｜耐药：被筛选出来的是细菌

主讲：甲　建议：80 秒　累计：11:15—12:35

甲：为什么不必要地用抗生素还会带来后续问题？可以借助高中生物的自然选择来理解。图中蓝色代表敏感细菌，红色代表具有耐药性的细菌。这些差异可以来自遗传变异，也可以来自耐药基因的获得。面对某种抗生素，敏感细菌更容易被抑制，具有相应耐药性的细菌可能存活并繁殖，于是群体中耐药菌的比例上升。图中的数量是教学示意，不是实验数据。这里最容易说错的一句话是“我的身体耐药了”。更准确地说，是病原菌对药物产生了抵抗能力。这个过程还涉及基因传播等因素，今天先记住选择压力这一条主线。

本页依据：S4; S5

13｜495 万与 127 万：是在回答两个问题

主讲：甲　建议：70 秒　累计：12:35—13:45

甲：两个数字不是两组互不重叠的人，而是用两种假设比较同一类耐药感染的负担。相关死亡约 495 万人，比较实际发生这类感染与没有这类感染。归因死亡约 127 万人，保留感染发生，但假设细菌对抗菌药物敏感，估计耐药性额外造成的死亡。一个问如果没有这类感染，一个问感染仍在但药能对付细菌。因此不能相加，也不能把 495 万全部说成耐药性额外造成，更不能全部归咎于个人乱用药。右侧两条独立条形共用从零开始的刻度，点和细线表示估计与 95%不确定性区间。这是 2019 年全球模型估计，发表于 2022 年。

本页依据：S5

14｜抗生素的三条行动规则

主讲：甲　建议：55 秒　累计：13:45—14:40

甲：回到我们自己能做的事，记住三条。第一，不因为感冒或嗓子痛就自行启用抗生素。第二，不把自己剩下的药分给室友，也不拿室友的处方照着用。第三，确实需要时按医生给出的剂量、间隔和疗程使用，不因为感觉好一点就自行停药，也不为了“彻底一点”擅自延长。这里不是让大家出现严重反应也硬撑着吃完，而是出现异常、疗效不理想，或不知道该如何继续时，及时联系医生或药师，由专业人员调整方案。

本页依据：S4

15｜考试周的“外挂”，谁在给它背书？

主讲：甲　建议：60 秒　累计：14:40—15:40

甲：考试周，小苏看见专注加倍、快速提分的广告，室友又说有人借用处方兴奋剂熬夜。悬念不是哪一种更厉害，而是广告和别人经验能否证明适合小苏。保健食品不能替代药物治疗疾病，功能声称不等于提分保证。处方兴奋剂对有适应证的患者，规范治疗有价值；借用他人处方进行非医疗使用，则存在失眠、焦虑、成瘾及过量等风险。合理用药要核实适用依据，不借用他人的处方，也不让考试焦虑替自己决定。

本页依据：S6; S7

16｜案例④：鼻子舒服了，上课却困了

主讲：甲　建议：75 秒　累计：15:40—16:55

舞台提示：此页末交接。甲累计 16 分 55 秒；乙从第 17 页开始。

甲：第四幕，小苏为了缓解过敏症状服了药，鼻子舒服了，坐进教室却特别想睡觉。这并不一定是药物没有起效，而可能是某些抗组胺药带来的嗜睡作用。有些药更容易让人困，有些相对较少，但个人反应也有差异。因此，选择时要说清自己的需求，例如白天有课、需要通勤，并向药师询问是否容易嗜睡。第一次使用时尤其应留意反应，困倦或反应变慢时，不要驾驶、骑车或做其他需要高度警觉的活动。也不要自己用酒精或其他药物去“抵消”这种感觉。

甲：为什么一种药既影响鼻子，也影响清醒程度？下面交给乙，接着用生物知识解释。

本页依据：S8

17｜同一种组胺信号，为什么有两种影响？

主讲：乙　建议：65 秒　累计：16:55—18:00

乙：左侧，组胺与 H1 受体相关的信号参与部分过敏反应；抗组胺药影响相应受体的作用，可以缓解部分症状。右侧，脑内组胺信号也参与维持清醒。血脑屏障是进入脑内的一道选择性屏障，不是对所有药物都完全封闭；部分抗组胺药能够进入脑内，影响相关受体信号，因此可能嗜睡。两条路径解释治疗作用与其他影响为什么可能同时发生，不表示每种药、每个人都一样。具体选择看说明书和药师建议；困倦时避开驾驶、骑车等高风险活动。

本页依据：S8; S14

18｜案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓

主讲：乙　建议：120 秒　累计：18:00—20:00

乙：第五个情境是聚餐。小苏白天吃了药，晚上被劝“就喝一点”。判断能不能一起用，不能只凭酒量，也不能只靠“上次没事”。酒精可能与多种药物相互作用，特别是与具有镇静作用的药物一起使用时，可能进一步影响警觉性和协调能力。对某些药物，风险还可能涉及肝脏、胃肠道等，但不同药物的机制和影响并不一样。

还有一个常见想法：把喝酒和吃药错开两小时就安全。这个时间不能通用，因为不同药物在体内停留的时间不同，饮酒情况和个体差异也会影响结果。拿不准时，最直接的行动是先不喝，带着具体药名去确认。

顺便说说送服药物。普通口服片剂和胶囊通常选择白水，并按说明书要求服用；不要默认咖啡、果汁、牛奶都能替代。但剂型有差别，例如含服或咀嚼的药物有自己的要求，所以最终仍然要看这盒药的具体说明。

本页依据：S8; S9; S13

19｜聚餐群里的建议，哪条先解决未知？

主讲：乙　建议：120 秒　累计：20:00—22:00

舞台提示：同桌讨论 20 秒＋举手约 25 秒；答案口头公布，不追问开放观点。

乙：今天服过抗过敏药，具体饮酒要求没确认。三个方案都像在控制风险：垫肚子并错开、沿用经验并少喝、换白水再核药名。请讨论二十秒，选更有依据的下一步。

【讨论 20 秒；依次举手各约 5 秒】

乙：答案 C。固定等两小时、酒不烈或以前没出事，都不能证明这一药品与酒精合用没有风险。信息未确认时先不喝，再查具体说明书或问药师。

本页依据：S8; S9

20｜安全用药四步：看、核、问、记

主讲：乙　建议：60 秒　累计：22:00—23:00

乙：第三部分，我们把前面的例子浓缩成四个动作：看、核、问、记。看，是观察症状，也看说明书和需要就医的信号。核，是核对成分有没有重复，剂量与时间是否符合要求，自己有没有相关禁忌。问，是把不确定的地方交给医生或药师确认，不用猜测填空。记，是记录已经用过的药、时间、用量以及出现的反应。上一题选 C，就把“这盒药能不能配酒”的不确定性变成了一个清楚的咨询问题。这四步是课堂助记法，不是替代诊疗的专业流程。

本页依据：S1; S2; S8; S9

21｜说明书很长？先定位这六处

主讲：乙　建议：90 秒　累计：23:00—24:30

乙：看到密密麻麻的说明书，不少人的反应是只找“一次几片”。更有效的办法，是先定位六类信息。第一，成分和通用名，解决“我究竟在吃什么”。第二，适应证，确认它用于什么情况。第三，用法用量，包含每次多少、间隔多久以及如何服用。第四，禁忌和注意事项，查看过敏史、既往疾病和特殊人群等相关要求。第五，相互作用与不良反应，看看与其他药物、食物饮料是否存在需要注意的地方。第六，贮藏条件和有效期，确认药品是否仍适合使用。

这张是重新设计的阅读示意，不是实际产品的说明书，也不能替代完整说明书。如果处方要求与自己的理解不一致，应向开方医生或药师核实，而不是自己随意选一种理解执行。

本页依据：S1; S2; S8

22｜时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

主讲：乙　建议：70 秒　累计：24:30—25:40

乙：用药过程中的很多问题，不是药选错了，而是自己改变了使用方式。比如漏了一次，不要自动理解成下次吃双倍。不同药物的处理方法不同，先查说明书，拿不准就问药师。再比如疗程，按处方使用，同时留意症状与反应；出现疑问要及时沟通，不能自行加量或延长。还有剂型，一些缓释或肠溶制剂依赖特定结构控制释放位置和速度，随意掰碎、咀嚼或打开胶囊，可能改变原先设计。也不是说所有带刻痕的药都不能分，而是能不能分、怎样分，应以具体产品说明为准。

本页依据：S10; S13; S4

23｜问药师时，把信息一次说清

主讲：乙　建议：60 秒　累计：25:40—26:40

乙：咨询是否有效，很大程度取决于我们提供的信息。可以按三句话组织。第一，我有什么症状，持续多久，正在变好还是加重。第二，我正在使用哪些药物或保健食品，具体药名和规格是什么，已经什么时候用了多少。第三，我有哪些已知药物过敏史、既往疾病或特殊情况。最好把药盒和说明书带上，或者拍清楚成分、规格和用法用量。只说“那种白色药片”，专业人员也难以准确判断。如果需要描述私密情况，可以单独咨询，不必在课堂或宿舍群里公开。

本页依据：S2; S1

24｜什么时候，不该继续自己试药？

主讲：乙　建议：75 秒　累计：26:40—27:55

乙：合理用药还包括知道什么时候停止自己试错。用药后出现呼吸困难、喉部或舌头肿胀、明显意识异常等情况，可能是严重反应，应立即寻求急救，在国内拨打 120。不要靠继续加药来压住症状。怀疑超量或误服，也要及时获得医疗帮助，有些问题并不一定马上表现出来。就诊时带上药盒和已经服用的时间、用量记录。如果不是急症，但症状持续、反复或越来越重，也应该按药品说明书的就医提示及时就诊。我们列的是几个重要信号，不是完整清单，更不是要大家在宿舍自行鉴别各种严重疾病。

本页依据：S2; S11; S12

25｜宿舍药箱：留信息，也留秩序

主讲：乙　建议：65 秒　累计：27:55—29:00

乙：说到药箱，最重要的不是囤得多，而是需要时能认清。药品尽量保留原包装和说明书，避免把不同药片混在一个没有标签的小盒子里。检查有效期，也检查包装上的贮藏要求，不能把“放冰箱”当作所有药物的统一保存方法。自己的处方药不要分享给室友，过期或不再需要的药品按当地药品回收或分类要求处理。再保留一个简单的用药记录，例如手机备忘录，写药名、时间、用量和反应。这样复诊或咨询时，信息会比凭印象回忆更准确。

本页依据：S2; S4

26｜把五个误区，换成五个动作

主讲：乙　建议：60 秒　累计：29:00—30:00

乙：在进入挑战前，我们把五个案例各换成一个动作。两盒感冒药放在面前，先核对成分。感冒后想到抗生素，先确认是否真正需要。备考时有人推荐所谓外挂，不借用别人的处方药，也不相信保证提分的宣传。吃抗过敏药后感到困倦，查看注意事项并避开风险活动。聚餐想喝酒，先确认具体药物的要求。我们没有要求大家记住几十个药名，而是练习在几个关键位置停一下。下面的小测只组合这些已经出现的动作，没有新知识，也不需要计算。

27｜综合挑战：小苏今晚怎么安排？

主讲：乙　建议：60 秒　累计：30:00—31:00

乙：最后进入综合挑战，小苏再次登场。这次信息更完整：他今天已经服用一种复方感冒药，晚上觉得还没完全舒服，想再加另一盒，同时准备去聚餐。现在两盒药的成分没有核对，饮酒要求也不清楚，症状目前较轻，没有我们刚才提到的严重急症表现。这里不要求大家诊断他得了什么病，也不要求给他开药，只选一个更稳妥的下一步方案。请记住三个线索：已经服过药、还没核对成分、聚餐可能喝酒。下一页有三个方案，答案不会藏在复杂医学知识里。

28｜小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

主讲：乙　建议：90 秒　累计：31:00—32:30

舞台提示：阅读 10 秒＋举手约 25 秒；甲负责观察，乙主讲。

乙：这次可以采纳多条建议。A 处理聚餐饮酒的不确定性，B 准备药盒和已服记录，C 沿用上次经验调整第二盒的时间。请判断哪些能补齐题目里的未知信息，再把采纳的建议拼成小苏今晚的计划。

【静默 10 秒；依次举手各约 5 秒，可以多次举手】

乙：先保留选择。下一页分别核对饮酒、成分与已服情况，不用靠哪个选项最长来猜。

29｜答案 A＋B：把建议拼成完整行动

主讲：乙　建议：90 秒　累计：32:30—34:00

舞台提示：乙揭晓；甲补充就医边界约 15 秒，再交回乙。

乙：A 与 B 可以一起采纳。A 在饮酒要求明确之前先不喝，B 把具体药名、规格、成分、何时用了多少一起交给药师核对。C 沿用上次经验把药改到睡前，没有解决现在的重复成分和累计使用问题。

甲：症状持续、加重或出现呼吸困难、意识异常等急症表现，要转为就医或急救。

乙：两条建议拼成完整行动，才比一个听起来谨慎的安排更有依据。

本页依据：S2; S4; S9; S11; S12

30｜药可以常备，判断不能省略

主讲：乙　建议：60 秒　累计：34:00—35:00

舞台提示：甲乙共同收尾；参考文献附页不逐页讲解。

乙：最后，我们把今天的内容收在三句话里。第一，先看说明书，再做用药决定，不让包装和熟悉感替我们判断。第二，核对重复成分，并记录已经服用的药物、时间和用量。第三，遇到不确定的信息，向医生或药师询问；该就医的时候，不继续靠自己试药。

甲：希望下一次室友拿出药盒时，大家能多做一个核对动作，多问一个具体问题。

乙：药可以常备，判断不能省略。谢谢大家。我们的数据出处和参考资料放在后面的附页，方便课后查阅。

【留出约 10 秒结束停顿；不在 35 分钟内另加开放讨论。】

互动答案速查

题目	题目页	揭晓位置	答案
开场选择（单选）	3	4	B
重复成分（多选）	9	10	A＋C
聚餐饮酒（单选）	19	19 页口头＋20 页提示	C
综合挑战（多选）	28	29	A＋B

参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml

[S2] FDA. Don’t Overuse Acetaminophen.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen

[S3] Wolf MS, et al. Risk of Unintentional Overdose with Non-Prescription Acetaminophen Products. J Gen Intern Med. 2012;27:1587–1593. DOI: 10.1007/s11606-012-2096-3.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3509295/

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do’ s and Don’ ts.

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

[S5] Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399:629–655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8841637/

[S6] FDA（2023）Updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions.

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-communications/fda-updating-warnings-improve-safe-use-prescription-stimulants-used-treat-adhd-and-other-conditions

[S7] 市场监管总局《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_d03ccbcf0c7e482198c4adfa23f9e59a.html

[S8] NHS. Antihistamines.

https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/

[S11] CDC. Manage Common Cold.

https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html

[S12] NHS. Anaphylaxis.

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

[S13] NHS. Omeprazole.

https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/